

孙志广基于“肝脾理论”治疗腹泻型 肠易激综合征医案报道 1 则[※]

王思霖[△], 王杰, 杨伟, 梁春耕, 尚莹莹[✉]

(上海市嘉定区中医医院, 上海 201800)

【摘要】 腹泻型肠易激综合征(IBS-D) 是常见的功能性消化系统疾病, 患者以腹痛、腹泻为主要症状, 且多难以控制, 伴情绪异常改变, 导致生活质量显著下降, 严重危害其身心健康。近年来, 临床中 IBS-D 患者数量逐渐增多, 而中医药在功能性泄泻的治疗中展现出良好疗效。孙志广教授基于五行及脏腑理论, 提出 IBS-D 当从肝、脾两脏论治, 强调木疏土升, 认为气机运行依赖肝脾协调, 且该病的发生与环境、饮食、情绪等多种因素相关, 治疗需兼顾三焦气机。孙志广教授以自拟方参葛健脾汤为基础, 配伍疏肝理气、清热化湿之品, 体现了肝脾同治、三焦兼顾的诊疗特色。该文通过分析孙志广教授的临床医案及用药规律, 总结其肝脾理论特点及方药思想。

【关键词】 腹泻型肠易激综合征; 泄泻; 肝脾理论; 参葛健脾汤; 孙志广

中图分类号: R249 文献标识码: B

DOI: 10.19621/j.cnki.11-3555/r.2025.2123

腹泻型肠易激综合征(diarrhea-predominant irritable bowel syndrome, IBS-D) 是一种以腹痛伴排便性状或频率改变为主要症状的功能性胃肠疾病^[1]。罗马 IV 标准将肠易激综合征分为 4 种类型^[2], 其中 IBS-D 在临床中较为常见且发病率较高, 全球发病率约为 1.2%(1.1%~1.3%)^[3]。IBS-D 的发病机制可能与脑肠轴异常、肠道菌群失调、内脏超敏反应等因素相关^[4-5], 西医治疗多采用解痉剂、止泻剂、抗抑郁药、肠道微生物制剂等对症治疗^[6]。中医将该病归于“泄泻”

[※]基金项目: 上海市嘉定区卫生健康委员会中医药科研课题(2020-KY-ZYY-05); 嘉定区公立医院改革与高质量发展示范项目中西医结合重点学科(专科)与中医优势专科建设项目(JDZXYSZK01)

✉通信作者: 尚莹莹, E-mail: shangyingying2001@163.com

△第一作者: 王思霖, E-mail: 806920774@qq.com

范畴^[7]。“泄泻之本, 无不由于脾胃”“湿胜则濡泄”, 故泄泻的主要病机是脾虚湿盛^[8], 故治脾调脾为治疗之本, 但亦需兼顾肝之疏泄, 正如《医方考》所曰: “泻责之于脾, 痛责之于肝, 肝责之实, 脾责之虚, 脾虚肝实, 故令痛泻。”肝主疏泄, 若疏泄失常则气机郁滞, 木旺乘土, 致肝脾不和, 发为泄泻^[9-10]。中医治疗泄泻时依据疾病的发展阶段辨证施治, “先祛邪、后固本”^[11]。孙志广教授为南京中医药大学博士研究生导师, 主任中医师, 从事消化科临床工作近 40 年, 对功能性消化系统疾病有丰富的临床经验, 认为从肝脾入手是 IBS-D 的治疗关键。张莎等^[12]通过 Meta 分析证实, 从肝脾辨治 IBS-D 疗效可靠、安全性好、复发率低。现将孙志广教授治疗 IBS-D 的典型医案、肝脾论治理论及用药思路总结如下, 为临床提供参考。

1 医案报道

患者, 女, 51 岁, 2022 年 3 月 5 日初诊。主诉: 大便次数增多 1 个月余。现病史: 患者 1 个月前无明显诱因出现大便次数增多, 每日排便 3~4 次, 大便尚成形、夹有黏液, 肠鸣音亢进, 腹痛、便后痛解, 无呕血黑便, 无畏寒发热, 胃纳一般, 小便调, 夜寐欠安。既往史: 否认高血压病、冠状动脉粥样硬化性心脏病、糖尿病等慢性病史; 否认相关传染病病史; 否认重大手术、外伤等病史。专科查体: 腹软, 腹部无压痛、反跳痛、肌紧张, 肝脾肋下未及, 墨菲氏征(一), 移动性浊音(一), 麦氏点无压痛、无反跳痛, 双下肢无水肿。舌淡胖, 苔薄白, 脉细弱。辅助检查: 未见明显异常。西医诊断: 腹泻型肠易激综合征。中医诊断: 泄泻病(脾虚湿滞证)。方选: 参葛健脾汤加减。组成如下: 党参片 12 g, 茯苓 15 g, 麸炒白术 15 g, 炒白芍 15 g, 葛根 30 g, 黄连片 6 g, 仙鹤草 30 g, 陈皮 10 g, 合欢皮 12 g, 木香 10 g, 柴胡 10 g, 当归 12 g, 广藿香 10 g, 苦参 6 g, 炒酸枣仁 30 g。14 剂, 每日 1 剂, 水煎取汁 200 mL, 早晚温服。服药期间嘱患者忌辛辣刺激食物, 节饮食、畅情志、避风寒, 适度加强运动锻炼, 增强体质。

2022 年 3 月 19 日复诊: 患者大便次数较前明显减少, 大便日行 1 次, 尚能成形, 腹痛较前明显缓解, 无肠鸣音亢进, 无呕血黑便, 无畏寒发热, 纳食一般, 夜寐欠佳, 小便正常, 舌质红, 苔黄腻, 脉弦滑。体格检查: 未见明显异常。辅助检查: 未见明显异常。西医诊断: 肠易激综合征。中医诊断: 泄泻病(脾虚湿热证)。方药

在初诊方基础上加減,调整为:党参片 12 g,茯苓 15 g,麸炒白术 15 g,炒白芍 20 g,葛根 30 g,黄连片 6 g,仙鹤草 30 g,陈皮 10 g,合欢皮 12 g,木香 10 g,柴胡 12 g,当归 12 g,广藿香 12 g,苦参 10 g,炒酸枣仁 30 g,徐长卿 15 g(后下),14 剂,煎服法同前,巩固治疗。

按语:患者为围绝经期女性,症状易受情绪、饮食等诸多因素影响。肝五行属木,木主升发,主气机疏泄,调畅气机为治肝之道;脾五行属土,土主运化,主气血运行,调理气血为治脾之要。木与土相克相乘,脾虚则木旺,补脾可疏理肝气,故从肝脾论治是治疗本病的关键。初诊时患者大便频数,伴腹痛,舌淡胖,苔薄白,脉细弱,为脾胃气虚,运化失常,脾气下陷,兼湿邪蕴结于中焦,致气机阻滞,进而引发的泄泻,故选用参葛健脾汤加減治疗。方中党参、茯苓、麸炒白术、炒白芍健脾利湿,葛根升举脾阳,黄连、苦参利湿,仙鹤草收敛补虚,木香、陈皮燥湿健脾、行气止痛,砂仁温脾止泻,合欢皮、柴胡疏肝安神、调理气机,当归、炒酸枣仁理气活血、安神助眠,广藿香芳香化湿。复诊时患者大便次数及腹痛症状较前明显改善,但纳寐仍未改善,察其舌脉,舌质红,苔黄腻,脉弦滑,孙志广教授认为此乃湿邪久郁而化热之象,进而影响脾胃,胃不和则卧不安,故表现为纳寐欠佳。因此,在初诊方基础上,增加炒白芍、柴胡、广藿香、苦参的剂量,以清化中焦湿热、敛阴和胃,继用酸枣仁安神助眠,并加归肝、胃经的徐长卿以祛湿止痛。

2 基于“肝脾论治”分析 IBS-D 病机

孙志广教授在治疗 IBS-D 患者时发现,脾胃功能失调是本病发生发展的核心。脾主升清、主运化,可助气血津液运行,若湿邪等致病因素侵袭,可致脾失运化、升降失常,而湿邪为重要的致病邪气,湿浊内停进一步阻滞气机,形成气滞、气瘀、气停。脾失健运则水谷不化,水湿下注大肠,而大肠主司津液代谢,气机不畅则津液不归正化、清浊不分,引发气机不畅之泄泻、腹痛^[13]等 IBS-D 症状。

肝脏是机体气机运行的重要器官,主疏泄而调畅气机。当前大多数 IBS-D 患者因病情反复迁延,常伴抑郁、焦虑、不安等情绪异常,而肝主怒、脾主思,肝失疏泄易致脾失运化,进而加重患者临床表现,故疏肝理气是调控病情的关键环节。当前日出而作、日落而息的传统生活习性已不复存在,取而代之的是作息紊乱、

暴饮暴食的快节奏高压生活,这打破了脏腑的正常运行节律,导致病情呈加重趋势。近 3 年,笔者跟随孙志广教授门诊发现,IBS-D 患者舌质多为淡白舌、紫舌,亦见少量裂纹舌(多由病情久滞、久病泄泻耗伤津液、损伤正气所致),舌苔以滑苔、白苔、腻苔较为多见;脉象方面,大多数患者夹有弦、滑之脉,亦有少数患者夹有细弱之脉。上述舌脉明确反映出患者体内多夹湿邪,病重者常伴正气亏虚。基于此,孙志广教授治疗 IBS-D 患者常以疏肝理气、益气生津、祛湿健脾为主,通过恢复木之条达、土之运化,使气血充盈通行,这是本病治疗的主攻方向。肝脾共主气机升降,通过疏调肝脾气机治疗 IBS-D 具有良好的临床疗效,且后续诊疗反馈显示,患者泄泻、腹痛等症状均明显改善,进一步印证了 IBS-D 从肝脾论治的科学性与有效性。

3 参葛健脾汤的组方和用药分析

孙志广教授常选用自拟方参葛健脾汤加減治疗 IBS-D,参葛健脾汤是参苓白术散合葛根芩连汤的加減方。参苓白术散是治疗脾虚湿盛证的经典方,在补脾运脾的同时可兼利湿化浊^[14]。孙志广教授认为,单独调脾难以根治本病。脾为生痰之源,且易夹湿,湿邪黏滞难祛,久则内生郁热,形成痰湿化热兼气机郁滞之象,而葛根芩连汤具有解表清理的功效^[15]。现代药理学研究发现,葛根芩连汤具有抗腹泻、增强机体免疫、抗炎、抗氧化、调节肠道菌群等作用^[16-17]。孙志广教授在参苓白术散的基础上合用葛根芩连汤加減治疗 IBS-D,临床疗效显著,得到患者较好的反馈。参葛健脾汤的基础方药为党参、茯苓、麸炒白术、紫苏梗、葛根、黄连、炒白芍、仙鹤草、木香、砂仁、陈皮。方中党参益气扶脾渗湿,麸炒白术、炒白芍益气健脾敛阴,三药合用固守中焦、益气敛阴,使气机开阖有度、补益不过,孙志广教授临床中党参的常用量为 12~20 g,麸炒白术、炒白芍的常用量为 12~15 g。陈皮、茯苓行气渗湿健脾,孙志广教授认为茯苓的利下作用较强,脾虚体弱患者须慎用剂量,避免进一步伤脾,肝脾型泄泻重在调理气机、运化湿邪,茯苓能使湿邪下利、气血运化,临床中陈皮常用量为 10 g 左右,茯苓常用量为 12~20 g。葛根升阳止泻,黄连清热燥湿,二药联合,升中有降,孙志广教授临床中葛根常用量为 12~15 g,黄连常用量为 6~10 g,痰湿化热明显者,葛根可用至 30 g,黄连可用至 10 g。仙鹤草入肝、脾经,能补虚收敛,孙志广教

授临床中仙鹤草常用量为10~30 g,气虚甚者,仙鹤草可用至30 g,以加大补虚收敛的功效。紫苏梗宽胸理气,木香行气止痛,砂仁温脾止泻,三药合用可畅通三焦气机、助气行血,兼顾上下二焦气机运行,缓解IBS-D患者腹痛、腹泻等症状,孙志广教授临床中紫苏梗常用量为12~20 g,木香常用量为10 g,砂仁临床常用量为6 g。上述方药及用量为孙志广教授临床辨证施治的常用参考,临证时仍需结合患者症状轻重、体质差异具体分析。

4 辨证论治与临床用药加减

孙志广教授认为,参葛健脾汤具有健脾理气、清热化湿的功效,全方重在调理脾胃,兼顾疏理气机,意从肝脾论治,改善患者腹痛、腹泻症状,助气血运行,提高机体免疫,恢复肠道功能。患者伴有气机不畅或情绪改变,且舌质暗红或青紫或两侧夹有瘀点,舌苔偏黯或黑,脉偏弦或涩时,孙志广教授常加木香、郁金、当归、川芎、丹参等理气活血药物,以调理气机、活血化瘀,改善气血运行。患者伴湿热内蕴、里热炽盛,见舌质红或绛红或有点刺、裂纹,舌苔偏黄或腻,脉偏数或滑时,孙志广教授常加苦参、石膏、知母等燥湿清热滋阴药物,以清热燥湿兼护胃阴。患者伴有脾胃虚弱或面色不华或气血亏虚,见舌质淡红,舌苔白或有剥苔,脉偏细或缓或弱时,孙志广教授常加黄芪、女贞子等补益药物,以补脾益气养血。患者伴有小便淋沥不尽、小便灼热感、小便量少等症状时,孙志广教授常加猪苓、泽泻、垂盆草、半枝莲等利水渗湿药物,以通利小便、清热化湿。若患者年迈体弱、肝肾亏虚,且伴有阴液亏损等症状时,孙志广教授常加淫羊藿、巴戟天、怀牛膝、墨旱莲、女贞子等滋补肝肾药物,以益气养阴。综上,孙志广教授治疗IBS-D时先辨病情轻重,以“脾为核心、肝脾同调”为诊疗思想,重在先安未受邪之地,预防疾病传变,再结合证候灵活加减,以期达到最佳疗效。

5 小结

肝脾理论源自五行及脏腑理论,是孙志广教授治疗IBS-D的经验论治。泄泻基于肝,源于脾,肝为刚脏,五行属木,主疏泄条达,可宣畅气机,脾为后天之本,主运化水谷,气机的正常运行与转化依赖木之疏泄、脾之运化。现今生活中情志因素对疾病进展的影响愈发显著,若肝失疏泄,脾气过旺或郁结,或脾失运化,均会导致气机紊乱,进而产生气滞、气郁,甚至气

瘀。孙志广教授认为,IBS-D临床以脾虚、肝郁较为常见,理脾疏肝是治疗关键。其中健脾为核心,故用药以党参、茯苓、白术为建方基础;近年临床中受情志因素影响的IBS-D患者日益增多,其中慢性病患者更易因情绪波动加重病情,故疏肝亦是其治疗的重要环节。综上,IBS-D的治疗应以肝脾同调为基础,结合辨证加减,此为孙志广教授治疗IBS-D的精髓所在。

[利益冲突] 本文不存在任何利益冲突。

参考文献

- [1] FORD A C, SPERBER A D, CORSETTI M, et al. Irritable bowel syndrome[J]. Lancet, 2020, 396(10263): 1675-1688.
- [2] 李彦楠, 杨丽旋, 赵钟辉, 等. 《2020年中国肠易激综合征专家共识意见》解读[J]. 中国临床医生杂志, 2021, 49(10): 1151-1155.
- [3] SAVARINO E, ZINGONE F, BARBERIO B, et al. Functional bowel disorders with diarrhoea: clinical guidelines of the United European Gastroenterology and European Society for neurogastroenterology and motility[J]. United European Gastroenterol J, 2022, 10(6): 556-584.
- [4] 张开波, 李鲜, 张璐鹏, 等. 腹泻型肠易激综合征的中西医结合研究现状[J]. 中国中西医结合消化杂志, 2021, 29(4): 298-302.
- [5] 李绅绅, 李清梅, 汤善能, 等. 基于脑肠互动中药干预腹泻型肠易激综合征的研究进展[J]. 河南大学学报(医学版), 2023, 42(6): 391-397, 441.
- [6] 中国中西医结合学会消化系统疾病专业委员会. 肠易激综合征中西医结合诊疗共识意见(2017年)[J]. 中国中西医结合消化杂志, 2018, 26(3): 227-232.
- [7] 中华中医药学会脾胃病分会. 肠易激综合征中医诊疗专家共识意见(2017)[J]. 中医杂志, 2017, 58(18): 1614-1620.
- [8] 中华中医药学会脾胃病分会. 泄泻中医诊疗专家共识意见(2017)[J]. 中医杂志, 2017, 58(14): 1256-1260.
- [9] 王玲玲, 柏茂树, 吴至久. 基于AQP3/Claudin-1研究痛泻要方治疗腹泻型肠易激综合征模型大鼠的机制[J]. 辽宁中医杂志, 2024, 51(3): 200-204.
- [10] 沈正寅, 单静怡, 朱凌宇. 加味痛泻要方治疗腹泻型肠易激综合征肝郁脾虚证的临床疗效观察[J]. 广州中医药大学学报, 2024, 41(3): 562-568.
- [11] 林欣蓉, 郭绍举, 李海文, 等. 腹泻型肠易激综合征病例证素分布及用药规律研究[J]. 广州中医药大学学报, 2022, 39(3): 485-490.

- [12]张莎,王文,李哲,等.从肝脾辨治腹泻型肠易激综合征的Meta分析[J].中医药导报,2016,22(20):69-73.
- [13]盛天骄,耿晓,孙笑然,等.加减葛根芩连汤治疗脾胃湿热型腹泻型肠易激综合征临床疗效[J].临床军医杂志,2020,48(9):1039-1041.
- [14]徐博文,徐海丰,程晨.参苓白术散加减对腹泻型肠易激综合征脾虚湿盛证患者血清胃肠激素水平的影响[J].检验医学与临床,2024,21(4):530-532,537.
- [15]黄玉龙,李枝锦,吴平财.葛根芩连汤治疗腹泻型肠易激综合征脾胃湿热证疗效观察与机制研究[J].中国中医基础医学杂志,2022,28(12):2015-2017.
- [16]舒雁,惠华英,谭周进.葛根芩连汤对泄泻肠道湿热证小鼠肠道双糖酶活性的影响[J].中国微生态学杂志,2021,33(11):1254-1258.
- [17]LI X Y,ZHANG C Y,HUI H Y,et al.Effect of Gegenqinlian decoction on intestinal mucosal flora in mice with diarrhea induced by high temperature and humidity treatment[J].3 Biotech,2021,11(2):83. (收稿日期:2024-04-28)

[编辑:郝利珍]

手术治疗复杂性肛瘘癌变病例报道^{*}

常俊莲^{1△},管忠安^{2✉}

(1. 山东中医药大学,山东 济南 250355;

2. 山东中医药大学附属医院,山东 济南 250011)

【摘要】 源于肛瘘的肛周黏液腺癌临床较为少见,症状缺乏特异性,诊疗存在一定困难。该文回顾性分析1例复杂性肛瘘癌变患者的临床资料,包括病史、诊断过程、治疗方式及预后,并结合相关文献进行复习,探讨该病的临床特点及诊疗要点,以期为临床治疗该病提供参考。

【关键词】 肛周黏液腺癌;锁肛痔;腹腔镜下直肠癌根治术;化疗

中图分类号:R249 文献标识码:B

DOI:10.19621/j.cnki.11-3555/r.2025.2124

在全部结直肠恶性肿瘤中,发生于肛管及肛周的

^{*}基金项目:齐鲁中医药优势专科集群项目(YWC2022ZKJQ0003)

✉通信作者:管忠安,E-mail:gwy199153@sina.com

△第一作者:常俊莲,E-mail:2291493148@qq.com

腺癌仅占约1%^[1];在所有肛管肿瘤中,发生于肛管及肛周的腺癌所占比例亦低于10%^[2]。其中,源于肛瘘的肛周黏液腺癌为重要亚型之一。目前,关于该病的发病机制及生物学行为仍存在争议,临床亦缺乏规范的诊疗指南。为提高临床对此类疾病的诊疗水平,现将1例典型肛瘘癌变病例的治疗过程报告如下,以供同道参考。

1 病案资料

患者,男,65岁,因“肛周疼痛伴流脓水3个月余”于2023年7月19日入院。患者30年前曾于当地医院诊断为“肛瘘”,并先后接受2次肛瘘手术(具体术式不详);12年前再次因“肛瘘”于当地医院行手术治疗(具体术式不详)。近3个月来,肛周出现质硬肿物并逐渐增大,累及左侧臀部,伴多处外口破溃、流脓,未经系统治疗,遂就诊于山东中医药大学附属医院。入院查体:双侧腹股沟区、锁骨上及腋窝未扪及包块;腹部未见窦道外口及手术瘢痕,无膨隆、压痛及反跳痛,肠鸣音正常。左侧臀部可见片状陈旧手术瘢痕。指诊:后位可触及内口,呈条索状通向肛内,退指后指套染有胶冻样脓血性物;因患者无法耐受,未行肛门镜检查。高度怀疑肛瘘癌变,遂留取分泌物送检,并完善肛周及腔内彩超、肛周增强CT检查。予中成药复方黄柏液涂剂(山东汉方制药有限公司,国药准字Z10950097,每1 mL相当于饮片0.2 g)灌肠以控制局部症状,并于局麻下取局部病变组织送病理检查。实验室检查:癌胚抗原(CEA)20.10 ng/mL;脱落细胞学检查见少量异型细胞团,形态符合恶性肿瘤细胞,建议结合临床评估。影像学检查:肛门彩超提示肛周脓肿合并高位肛瘘,肛管前壁黏膜层低回声(考虑炎症),肛管前壁内括约肌层明显增厚,肛管左侧壁低回声(考虑瘢痕)。胸腹增强CT示肛管及直肠远端壁弥漫性增厚、明显强化,并累及肛提肌及臀部,感染性与占位性病待鉴别,建议进一步检查。局部病变组织病理回报:(肛门病变)被覆鳞状上皮及腺上皮黏膜呈慢性炎症,局部见融合的异型腺体,结合形态学及免疫组化结果判断符合直肠型腺癌。免疫组化结果:细胞角蛋白20C(CK20C)(+),CK7(-),人表皮生长因子受体-2(Her2)(1+),细胞增殖活性标志物Ki-67(60%),CK5/6(-),细胞核内蛋白P40(-),细胞核内蛋白P63(-),囊泡病液体蛋白-15(GCDFP-15)(-),黏蛋白2